

Rạch màng xơ và ghép

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật làm thẳng dương vật (bệnh Peyronie)

WARWIKI

Bệnh Peyronie gây ra một mảng sẹo bên trong dương vật khiến dương vật bị cong khi cương, đôi khi gây khó khăn khi quan hệ. Trong phẫu thuật này, mảng sẹo ở phía ngắn, căng của dương vật được rạch (và đôi khi cắt bỏ một phần) để giải phóng độ cong, rồi vá khoảng hở bằng một mảnh ghép. Tờ thông tin này giải thích cách thức hoạt động, cách chuẩn bị và những điều cần biết.

Về thủ thuật này

Mảng sẹo co kéo một bên dương vật, khiến dương vật bị cong khi cương. Phẫu thuật này giải phóng độ cong bằng cách rạch qua sẹo ở **phía ngắn (bên trong)**; điều này tạo ra một khoảng hở được lấp đầy bằng **mảnh ghép** — miếng vá mỏng (chẳng hạn miếng collagen, mô người hiến/động vật, hoặc mô từ cơ thể bạn). Vì phương pháp này kéo dài phía ngắn thay vì rút ngắn phía dài, nó **bảo tồn chiều dài dương vật**.

Phương pháp này được chỉ định khi:

- Độ cong **nặng hoặc phức tạp** (ví dụ hình đồng hồ cát hoặc biến dạng bàn lễ)
- Bảo tồn **chiều dài** là quan trọng (phương pháp khâu gấp sẽ rút ngắn quá nhiều)
- **Sự cương dương đủ mạnh** để chịu được phẫu thuật này

Điều cần biết

Ưu điểm là **chiều dài được bảo tồn** (đôi khi tăng nhẹ). Đổi lại, có **nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn** so với khâu gấp — do can thiệp vào sẹo có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ máu của dương vật — vì vậy chỉ thực hiện khi sự cương dương còn tốt. **Tê đầu dương vật** thường gặp sau mổ (các dây thần kinh được nhẹ nhàng dịch chuyển trong lúc mổ) và thường hồi phục sau 6–12 tháng. Hầu hết bệnh nhân có được cương thẳng để quan hệ.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Bệnh Peyronie

Mảng sẹo trong dương vật khiến dương vật bị cong khi cương.

Màng xơ (Plaque)

Vùng mô sẹo gây ra độ cong.

Mảnh ghép (Graft)

Miếng vá mỏng lấp khoảng hở sau khi sẹo được giải phóng — miếng collagen, mô người hiến/động vật, hoặc mô từ cơ thể bạn.

Cương nhân tạo

Sự cương được tạo ra trong phòng mổ (bằng tiêm) để phẫu thuật viên đo và kiểm tra độ cong.

Cắt bao quy đầu

Loại bỏ bao quy đầu — thường thực hiện cùng lúc nếu bạn chưa được cắt.

Phục hồi chức năng cương dương

Dùng thuốc cương và/hoặc thiết bị hút chân không trong quá trình lành để bảo vệ sự cương dương và chiều dài.

Gây mê toàn thân

Thuốc giúp bạn ngủ sâu và không đau trong suốt ca mổ.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, dương vật sẽ sưng, bầm và đau nhức trong 1–2 tuần — chườm đá, băng đỡ và thuốc giảm đau sẽ giúp ích. Phẫu thuật này lâu hơn khâu gấp (thường 1,5–3 giờ) và bạn có thể ở lại một đêm. Ống thông tiểu thường được đặt và rút vào sáng hôm sau.

Cách chuẩn bị (Trước phẫu thuật)

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống** — tuân thủ mọi hướng dẫn phẫu thuật (nhịn ăn, thuốc cần ngừng, kể cả thuốc làm loãng máu).
- Bệnh Peyronie phải **ổn định** (độ cong và cơn đau đã ổn định nhiều tháng), và **sự cương dương được kiểm tra** trước — phẫu thuật này cần chức năng cương tốt.
- Không hút thuốc**; mọi nhiễm trùng phải được điều trị trước, và bạn sẽ được dùng kháng sinh. Nếu chưa cắt bao quy đầu, thường được làm cùng lúc.

Hãy thông báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Có **sự cương dương yếu**, hoặc cần thuốc/tiêm để cương
- Đang dùng thuốc làm loãng máu, hoặc đã từng phẫu thuật dương vật trước đây

Quá trình phẫu thuật

- Bạn được gây mê hoặc gây tê; kháng sinh được dùng trước mổ.
- Tạo cương nhân tạo bằng tiêm** để xác định độ cong; da được bóc tách và các dây thần kinh trên dương vật được nhẹ nhàng dịch chuyển sang bên.
- Màng se phía gần được **rạch (và đôi khi cắt bỏ một phần)** để giải phóng độ cong, khoảng hở được vá bằng **mảnh ghép**; kết quả được kiểm tra và da được khâu lại.

Sau phẫu thuật

- Dự kiến **sưng, bầm và đau nhức** trong 1–2 tuần. **Tê đầu dương vật** thường gặp và thường hồi phục sau nhiều tháng.
- Ống thông tiểu thường được rút vào sáng hôm sau phẫu thuật.
- Tránh quan hệ khoảng 6–8 tuần** để mảnh ghép lành lại.
- Nhóm chăm sóc sẽ hướng dẫn **phục hồi chức năng cương dương** — thuốc cương liều thấp và/hoặc thiết bị hút chân không hằng ngày — để bảo vệ sự cương dương và chiều dài.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc vết thương ngày càng đỏ, đau, sưng hay chảy dịch
- Không thể đi tiểu
- Sưng hoặc đau nặng, ngày càng tệ hơn, hoặc chảy máu nhiều

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Phẫu thuật này giải phóng độ cong bằng cách rạch se phía gần và vá khoảng hở bằng mảnh ghép — **bảo tồn chiều dài**, dùng cho độ cong nặng hoặc phức tạp.
- Đôi lại là **nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn** so với khâu gấp, nên chỉ thực hiện khi sự cương dương còn tốt; tê đầu dương vật giai đoạn đầu thường gặp và thường hồi phục.
- Bệnh Peyronie cần ổn định và kiểm tra sự cương dương trước; không hút thuốc. Sau mổ, tránh quan hệ ~6–8 tuần và thực hiện phục hồi chức năng cương dương. Gọi cho nhóm chăm sóc nếu sốt, sưng nặng hoặc khó đi tiểu.